

FICHA TÉCNICA CLÍNICA: CAPE42

1. Identificación del Instrumento

Título original	Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE-42)
Título español	Evaluación Comunitaria de Experiencias Psíquicas (CAPE-42)
Sigla	CAPE-42
Autores originales	Stefanis, Hanssen, Smirnis, Avramopoulos y Van Os
Año original	2002
Adaptador español	Fonseca-Pedrero, Paino, Lemos-Giráldez et al.
Año adaptación	2008
Formato	Cuestionario de autoinforme de 42 ítems

2. Fundamentación Conceptual y Teórica

El CAPE-42 se basa en el modelo del continuo de la psicosis, el cual propone que las experiencias psicóticas (como suspicacia, alucinaciones o anhedonia) se distribuyen de forma continua a lo largo de la población general, variando en frecuencia y nivel de distress, sin requerir una esquizofrenia establecida.

3. Características Generales

Objetivo	Evaluar experiencias del espectro psicótico en la población general y de riesgo.
Población	Adolescentes, adultos jóvenes y población general.
Administración	Autoadministrado (aprox. 15 minutos).
Tiempo	Aproximadamente 15 minutos.
Corrección	Cálculo de la media para frecuencia e inquietud en tres dimensiones independientes.

4. Estructura y Dimensiones

Dimensión / Factor	Ítems	Invertidos	Descripción
Dimensión Positiva	20 ítems (ej. suspicacia, pensamientos mágicos)	No	Mide presencia de ideas delirantes y fenómenos alucinatorios breves.
Dimensión Negativa	14 ítems (ej. anhedonia social, abulia)	No	Mide el aplanamiento afectivo, aislamiento y falta de motivación.
Dimensión Depresiva	8 ítems (ej. tristeza, desesperanza)	No	Evalúa síntomas depresivos concurrentes.

5. Sistema de Puntuación

Cada ítem se puntúa doblemente: por un lado la Frecuencia (1 = Nunca, 2 = A veces, 3 = A menudo, 4 = Casi siempre) y por otro lado el Grado de Inquietud que genera (1 = Nada, 2 = Un poco, 3 = Bastante, 4 = Mucho). Las puntuaciones de distress solo se responden si la frecuencia es > 1.

6. Interpretación de Resultados y Baremos

Se calculan las puntuaciones medias para cada una de las tres dimensiones. Permite caracterizar perfiles psicopatológicos preclínicos y detectar de forma temprana estados de riesgo mental.

7. Evidencia Psicométrica (Confiabilidad y Validez)

El CAPE-42 cuenta con una alta fiabilidad en todas sus dimensiones (consistencia interna con Alfa de Cronbach superior a 0.80). Muestra una validez predictiva sólida para el desarrollo posterior de trastornos psicóticos formales.

8. Adaptaciones y Validaciones en Español

Validado en España por Fonseca-Pedrero y colaboradores, el cuestionario mantiene una estructura trifactorial idéntica y una robusta validez clínica en la población adolescente e hispanohablante.

9. Aplicaciones Prácticas

Investigación en salud mental, cribado escolar de estados de riesgo de psicosis y prevención comunitaria.

10. Fortalezas del Instrumento

- Cubre tanto la frecuencia como el distress psicosocial asociado.
- Excelente para población no clínica y detección precoz.

11. Limitaciones Clínicas y Metodológicas

- Puede generar falsos positivos si no se evalúa de manera individual la repercusión funcional real.

12. Consideraciones Éticas y Legales

Requiere un manejo ético cuidadoso de las puntuaciones para evitar la estigmatización y falsas etiquetas de psicosis.

13. Síntesis Técnica General

El CAPE-42 es una de las herramientas de autoinforme más importantes a nivel mundial para explorar la vulnerabilidad psicótica y esquizotípica en el ámbito comunitario.

14. Referencias Bibliográficas (APA 7)

- Stefanis, N. C., et al. (2002). The Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE): development and psychometric properties. *Schizophr Res*, 53(1), 123-134.
- Fonseca-Pedrero, E., et al. (2008). Estructura factorial del Community Assessment of Psychic Experiences (CAPE) en adolescentes. *Actas Esp Psiquiatr*, 36(5), 263-269.